**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre**

Rua Manoelito de Ornelas, 50, Sala 1107, 11º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent12vciv@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5015252-90.2023.8.21.0001/RS**

**AUTOR**: ANNICELE DA SILVA ANDRADE GAMEIRO

**RÉU**: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

# SENTENÇA

**RESUMO DA SENTENÇA**

| | |
|---|---|
| **Petição inicial**<br>Autora é portadora de esclerose múltipla e oftalmopatia de graves, sendo indicado por seu médico o tratamento com imunoglobulina humana.<br><br>**Pedido**<br>Custeio do tratamento com imunoglobulina humana, 150 gramas / ciclo (total de 6 ciclos) indicado pelo médico assistente. | **Contestação**<br>Não há previsão para cobertura de tratamento *off label*, conforme contrato e Rol da ANS. |
| **Pontos controvertidos / discussão do processo**<br>*Se o tratamento off label deve ser custeado pela operadora de autogestão*. | |
| **Provas**<br>*Documentos juntados comprovam que o tratamento é off label e a Autora possui oftalmopatia de graves.* | |
| **Conclusão**<br>*Tendo em vista inexistir tratamento indicado na bula para doença da Autora, impõe à Ré o custeio do indicado pelo médico assistente, ainda mais quando há expressa previsão de cobertura da doença da contratante em contrato.* | |
| **Dispositivo**<br>***Julgado procedente o pedido***. | |

**RELATÓRIO**

**ANNICELE DA SILVA ANDRADE GAMEIRO** ajuizou a presente ***Ação Cominatória*** contra **CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**, narrando ser portadora de esclerose múltipla, (CID 10 G35) e oftalmopatia de graves (CID 10 H05.1). Contou que realizou inúmeras tentativas de tratamento, sendo indicado pelo médico assistente o tratamento por imunoglobulina humana, capaz de conter o quadro inflamatório. Disse que a Ré negou o tratamento. Citou a cobertura contratual. Frisou ser beneficiária do plano de saúde CASSI FAMÍLIA II, n.° 1101506171510000. Requereu, em sede de antecipação de tutela, o fornecimento do medicamento imunoglobulina humana. Pleiteou, no mérito, a condenação da Ré ao custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente (Petição Inicial).

Concedida a gratuidade judiciária e a liminar.

Citado, o Réu contestou. Preliminarmente, impugnou a gratuidade judiciária. Frisou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Disse que o tratamento perseguido pela Autora não está especificado na bula (*off label*). Salientou a necessidade de comprovação científica da eficácia do medicamento no tratamento da doença. Mencionou o impacto nas políticas públicas de saúde (Contestação).

Houve réplica.

Nada mais, vieram para decisão.

**É o relatório. Decido.**

**FUNDAMENTAÇÃO**

A teor do art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgo o processo no estado em que se encontra.

Cuida-se de **Ação Cominatória,** em qual a Autora pretende a condenação da Ré ao custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente, consistente no fornecimento de IMUNOGLOBULINA HUMANA, 150 gramas / ciclo (total de 6 ciclos)

Há preliminares.

**Da Impugnação à Gratuidade Judiciária**

Tenho, inicialmente, que deva ser acolhida a impugnação à gratuidade judiciária, pois a Autora recebe mensalmente valor superior à cinco salários-mínimos, conforme seu contracheque.

Portanto, revogo o benefício da gratuidade judiciária.

**Da Impugnação ao Valor da Causa**

A impugnação ao valor da causa vai afastada, pois a Autora atribuiu o valor referente ao custo dos medicamentos que pretende o custeio por parte da Ré, gestora do seu plano de saúde.

Portanto, afasto.

**Do Código de Defesa do Consumidor**

Consoante a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, **salvo os administrados por entidades de autogestão.** Assim, inaplicável, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, pois a Ré o possui modalidade de autogestão em saúde.

Segue entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. NEOPLASIA DE PULMÃO. RADIOTERAPIA IMRT. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. SÃO INAPLICÁVEIS AS DISPOSIÇÕES ATINENTES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO A DEMANDADA É OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. 2. A INAPLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO NÃO IMPLICA INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ARTS. 421 E 422 DO CC). O ART. 423 DO CC DETERMINA QUE, NO CONTRATO DE ADESÃO, DEVE-SE ADOTAR A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. 3. A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO A SER ADOTADO DIANTE DA PATOLOGIA DO SEGURADO. O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA A DOENÇA APRESENTADA PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO E NÃO A FORMA COMO SEU TRATAMENTO SERÁ MINISTRADO. 4. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA COMPROVOU A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO CUJA COBERTURA FOI NEGADA PELA RÉ. DEVER DE RESSARCIMENTO MANTIDO. 5. CASO CONCRETO EM QUE A NEGATIVA DE COBERTURA EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR DOS PROBLEMAS COTIDIANOS, SENDO MANIFESTA A DOR, A ANGÚSTIA E O ABALO PSICOLÓGICO POR QUE PASSOU A PARTE AUTORA, PORQUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO ESPECIAL E ABALADA EMOCIONALMENTE. 6. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO, EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E COM O FIM DE ASSEGURAR O CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO, SEM CONSTITUIR-SE ELEVADO BASTANTE PARA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003986920178210141, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 31-08-2022)*

Entretanto, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessária análise do contrato sob a ótica dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil). Ainda, o art. 423 do Código Civil determina a interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão.

Portanto, mesmo não se tratando de relação de consumo, o Código Civil prevê a necessidade de proteção do vulnerável contratual.

**Da Cobertura do Tratamento**

A Autora é portadora de esclerose múltipla, (CID 10 G35) e oftalmopatia de graves (CID 10 H05.1), sendo indicado pelo seu médico assistente o tratamento por imunoglobulina humana, capaz de conter o quadro inflamatório.

Entretanto, por não possuir especificação na bula (*off label*) ou comprovação científica da eficácia do medicamento no tratamento da doença, a Ré negou o custeio do tratamento.

O tratamento *off label* é aquele que não está descrita na bula ou manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante, conforme o inc. X do art. 4° da **Resolução Normativa n.° 465**:

> *Art. 4º Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições:*
>
> ***X - uso off-label: uso de medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante.***

Em seu art. 17, inc. I, "c", a RN 465 autoriza a exclusão:

*Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.*

*Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:*

*I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que:*

*a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país;*

*b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou*

***c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde**, ressalvado o disposto no art. 24;*

Assim, no Contrato de Adesão, no art. 22 do Capítulo X - Dos Serviços e das Despesas Não Cobertos, ficou estipulada a exclusão da cobertura de tratamentos experimentas de qualquer espécie:

***CAPÍTULO X***

***DOS SERVIÇOS E DAS DESPESAS NÃO COBERTOS***

***CLÁUSULA 22** - Os seguintes serviços e despesas não serão cobertos pelo CASSI FAMÍLIA: acidente do trabalho e doenças ocupacionais; aparelhos estéticos e de substituição ou complementação de função (prótese e órtese) não relacionados ao ato cirúrgico; aplicações de injeções; vacinas; cirurgias refrativas, em caso de participante com menos de 18 (dezoito) anos e grau estável há menos de 01 (um) ano, para Miopia de graus inferior a 5,0 (cinco) e superior a 10,0 (dez), com ou sem Astigmatismo associado com grau superior a 4,0 (quatro), e para Hipermetropia com grau superior a 6,0 (seis), com ou sem Astigmatismo associado com grau superior a 4,0 (quatro); cirurgia plástica com finalidade estética ou social, mesmo que justificada por razão médica; compra ou aluguel de equipamentos, aparelhos e objetos; despesas extras em internações; despesas de acompanhantes, exceto para menores de 18 (dezoito) anos ou maiores de 60 (sessenta) anos de idade (somente o pernoite e café da manhã); tratamentos clínicos ou cirúrgicos que contrariem a ética médica ou não sejam reconhecidos pela comunidade científica; **tratamentos experimentais de qualquer espécie**; cirurgias com finalidade de mudança de sexo; enfermagem particular no hospital ou no domicílio; estada em estações de águas minerais, hotel, pensão, SPA, casas de repouso e similares; despesas com funeral; imobilizadores ortopédicos usados em substituição ao gesso; intervenções com finalidade contraceptiva que não a prevista em lei; inseminação artificial; lentes externas para qualquer deficiência visual; materiais e medicamentos para uso domiciliar; objetos de uso pessoal e produtos de higiene; reflexologia; psicodiagnóstico e psicoterapia que não a prevista em lei; suplementos alimentares; tratamentos para embelezamento; tratamentos no exterior; tratamentos da obesidade (exceto cirurgias para obesidade mórbida); tratamentos odontológicos de qualquer natureza; reeducação postural global; procedimentos não constantes no Rol de Procedimentos da ANS vigente na data do evento.*

Entretanto a exclusão não é automática, pois ressalvada quando (I) a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; e (II) a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 (art. 24).

Na mesma linha, o julgamento do REsp 1.886.929 / SP, que desautorizou o custeio de tratamentos não constantes no Rol da ANS, ressalvadas as hipóteses abaixo grifadas:

*1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;*

*2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;*

*3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;*

***4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.***

Por conseguinte, em adoção a essa ressalva, mostra-se abusiva a recusa do custeio do tratamento off-label ou experimental prescrito pelo médico quando necessário ao tratamento de enfermidade coberta pelo contrato - fato não impugnado nos autos. A propósito, assim já julgou o Superior Tribunal de Justiça:

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.*

*1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamentos para o tratamento de neoplasia mamária.*

***2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"** (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.*

*3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que há obrigatoriedade de fornecimento medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes.*

*4. Agravo interno não provido.*

*(AgInt no REsp n. 2.005.551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)*

Em verdade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) considera que o uso *off label* de medicamentos não é necessariamente incorreto, visto que um medicamento ser aprovado para determinada situação não implica que essa seja a única indicação possível. Na maioria das vezes, como no caso, o medicamente pode ser essencialmente necessário e correto.

Importante mencionar que a Autora é acometida por transtorno oftalmológico que ocasiona irritação da córnea, fotofobia e dor em ambos os olhos. Ademais, consta que a enfermidade vem ocasionando graves limitações ao dia a dia da autora, impedindo-a, inclusive, de trabalhar e de dormir.

Ainda, conforme indicado pelo médico da Autora no Atestado Médico, a oftalmopatia de graves é uma doença chamada de "órfã", pois não há tratamento indicado em bula (*on label*):

**Atestado Médico**

Atesto que ANNICELE DA SILVA ANDRADE é portadora de ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID: G35) e vem apresentando sintomas de diplopia, estrabismo, dor à movimentação ocular bilateral, e edema palpebral e hiperemia conjuntival. Quadro de OFTALMOPATIA DE GRAVES (CID: H05.1) com intensidade grave, pois já apresenta alterações de motricidade ocular e exoftalmia ambos olhos com irritação da córnea, fotofobia e dor. Usou prednisona oral na dose de 1 mg/kg/dia, sem sucesso. Realizou tratamento com METILPREDNISOLONA endovenosa, sem qualquer resposta sintomática. Como os sintomas da oftalmopatia estão causando muito desconforto e limitação funcional, impedindo inclusive de trabalhar e de dormir, deve realizar tratamento com IMUNOGLOBULINA HUMANA por 6 ciclos, para reduzir o quadro inflamatório e promover melhora sintomática. Trata-se de quadro grave, com risco de sequela visual PERMANENTE (decorrente de inflamação do nervo óptico e da córnea), caso nao se consiga reduzir os sintomas visuais.

Com relação à OFTALMOPATIA DE GRAVES, trata-se de complicação autoimune dos tecidos da órbita, causada pela TIREOIDOPATIA DE GRAVES. Ocorre em 50% dos pacientes com TIREOIDOPATIA DE GRAVES. No caso em questão, a paciente apresentou TIREOIDOPATIA DE GRAVES, vindo a utilizar tratamento com iodo radioativo, mas foi somente com a cirurgia de TIREOIDECTOMIA que veio a melhorar o quadro de disfunção tireodeana. Apesar do tratamento cirúrgico, apresenta atualmente o quadro de OFTALMOPATIA DE GRAVES. A maioria dos pacientes com oftalmopatia de Graves apresenta quadro leve a moderado da doença na órbita, sendo que 10% apresentam sintomas e sinais intensos, de maior gravidade e com risco de perda visual e dor limitante, afetando o trabalho e a realização das tarefas diárias. A OFTALMOPATIA DE GRAVES é uma doença chamada ÓRFÃ, ou seja, não possui tratamento com medicamentos com indicação em bula, em nosso País. Para tratamento dos sintomas agudos da doença (controle rápido da inflamação ocular e dos tecidos da órbita) não há tratamentos ON-LABEL. A rotina é a utilização de corticóides via oral e endovenosos (são os mais utilizados), e ainda há a possibilidade de uso de IMUNOGLOBULINA HUMANA (menos utlizada que os corticóides), nos casos que não respondem ao corticóide.

11 de Janeiro de 2023

Não possuindo previsão expressa em bula em nenhum medicamento, o tratamento usual é realizado com corticóides, sendo utilizada a imunoglobulina humana quando estes não surtem efeito.

Assim, mostra-se plausível a indicação de imunoglobulina humana, pois é indicada em casos de desordens imunológicas e inflamatórias específicas (ver **site**), sendo prevista em sua bula outras especificações. Outrossim, o médico justificou justamente por ser capaz de conter quadro inflamatório, conforme laudo.

A utilização da imunoglobina humana, registrada na ANVISA, sob o nº 1163700440161, autorização nº1016377, processo nº 25351.003171/00-41e validade até 01/09/2025, não foi a primeira indicação do médico assistente, que optou quando não vislumbrou uma melhora com o tratamento convencional.

Ressalto, por fim, que a Ré não indicou qualquer tratamento prescrito em bula capaz de melhorar o estado de saúde da Autora, limitando-se a alegar que não há comprovação científica da eficácia do tratamento.

Entretanto, não é possível recusar o fornecimento sob alegação de não comprovação científica acerca da sua eficácia, pois o médico é o profissional que conhece o quadro clínico do paciente e possui melhores condições de indicar o tratamento mais adequado. Inclusive, a limitação do critério médico na escolha de procedimento para o tratamento da doença é vedada expressamente pelo **XVI do Código de Ética Médica**:

*"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente".*

Segue entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

*APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DO AUTOR QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO PROCURADOR DA PARTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO OBSERVÂNCIA A REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NIVOLUMABE. CARCINOMA DE TESTÍCULO NÃO SEMINOMATOSO. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR VERSA TÃO SOMENTE SOBRE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA, SENDO, PORTANTO, DE INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO. EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADO, O PATRONO NÃO COMPROVOU FAZER JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, TAMPOUCO EFETUOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. 2. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 3. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE,*

*EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 4. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO. 5. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO.* ***6. ASSIM, TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA DO MEDICAMENTO NIVOLUMABE SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE (CARCINOMA DE TESTÍCULO NÃO SEMINOMATOSO), NÃO CONSISTINDO ÓBICE À COBERTURA EVENTUAL USO OFF LABEL DO FÁRMACO REQUERIDO, CONSIDERADA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA.*** *7. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível, Nº 50118738520218210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 26-10-2022)*

*APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÍNDROME DE DRESS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO IMUNOGLOBULINA HUMANA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES POSTERIOR À UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO. 4. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO.* ***5. ASSIM, TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA POSTULADA (IMUNOGLOBULINA HUMANA), SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE, NÃO CONSISTINDO ÓBICE À COBERTURA EVENTUAL USO OFF LABEL DO FÁRMACO REQUERIDO.*** *6. DE OUTRO LADO, TANTO A DOUTRINA COMO A JURISPRUDÊNCIA SINALIZAM PARA O FATO DE QUE OS DANOS MORAIS SUPORTADOS POR ALGUÉM NÃO SE CONFUNDEM COM OS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS COMUNS À VIDA EM SOCIEDADE, ESPECIALMENTE NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. 7. DESSA FORMA, NÃO É QUALQUER DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE SERÁ CAPAZ DE ENSEJAR REPARAÇÃO, PORQUE É NECESSÁRIO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, QUAIS SEJAM: A CONDUTA CULPOSA, O NEXO CAUSAL E O DANO. 8. IN CASU, A SITUAÇÃO RETRATADA CORRESPONDE A MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE DEVE SER VISTO COMO UM PROBLEMA QUE NÃO FUGIU À REGULARIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERFAZEM O CASO, INEXISTINDO EXCEPCIONALIDADE — CUJA COMPROVAÇÃO ERA INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PARA JUSTIFICAR A REPARAÇÃO MORAL. 9. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELOS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50044848120188210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-09-2022)*

Assim, diante da excepcionalidade do caso em que não há tratamento alternativo indicado para oftalmopatia de graves (CID 10 H05.1) incontroversamente coberta pelo contrato, tenho que deva ser custeado pela Ré.

Saliento, por fim, que a falta de informação expedida pela Conintec ou Natjus não é suficiente para afastar o direito da Autora, pois doenças de extrema raridade muitas vezes não possuem testes clínicos feitos, diante da baixa demanda.

Ainda, foi justificado o remédio por parte do médico assistente da Autora, sem que tenha sido impugnada a situação de "doença órfã" de não possuir medicamento com indicação na bula no Brasil.

Portanto, julgo **procedente** a presente ação.

**DISPOSITIVO**

**Ante o exposto**, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da lide, **JULGO PROCEDENTE** a presente ***Ação Cominatória*** ajuizada por **ANNICELE DA SILVA ANDRADE GAMEIRO** contra **CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.,** para fins de tornar definitiva a liminar concedida, condenando a Ré ao custeio do tratamento de IMUNOGLOBULINA HUMANA, 150 gramas / ciclo (total de 6 ciclos).

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador do Autor, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso(s) – excepcionados embargos de declaração – intime(m)-se, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, CPC, e 567, XX da Consolidação Normativa Judicial), a(s) contraparte(s) para contrarrazões, remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1010, § 3º, do CPC).

Transitada em julgado, arquive-se com baixa.

---

Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO RAUL KLIPPEL, Juiz de Direito**, em 11/5/2023, às 15:29:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10038012702v54** e o código CRC **fd82039b**.

---